

11 - 01- Les États Dépressifs - Pr. MANOUDI

Bonjour, aujourd'hui on va voir les états dépressifs. Les états dépressifs, parce qu'il y a plusieurs types de dépressions. A la fin de ce cours, vous devez être capable de définir un état dépressif, connaître l'intérêt de ce sujet, connaître les différentes composantes d'un syndrome dépressif, savoir diagnostiquer une dépression, connaître les différentes formes d'une dépression, faire le diagnostic différentiel devant une dépression, connaître l'éthiopathogénie, connaître les différentes formes évolutives, évaluer le pronostic et savoir mener un traitement d'une dépression.

La dépression se définit par tout sentiment de tristesse persistant, toute perte d'intérêt ou de plaisir dans la plupart des activités pendant une durée minimale de deux semaines. C'est un problème de santé publique majeur. En tant que médecin généraliste, et même quelle que soit votre spécialité, vous devez être capable de diagnostiquer une dépression et de bien traiter une dépression.

La prise en charge, elle est codifiée par des traitements qui sont connus et par des thérapies qui sont efficaces. Tout ça pour prévenir les complications dont les plus graves sont l'abus de substances psychoactives et les conduites suicidaires ou le suicide. La prévalence de la dépression est élevée avec une consommation importante en soins et en médicaments.

Il peut causer un handicap majeur, soit par l'absentisme, soit par les rechutes. Le traitement est efficace et, en règle, la dépression est bien traitée et on a une guérison après un traitement bien suivi. La prévalence sur la vie est de 12 à 25 %. 20 % de consultants chez les médecins généralistes est constitué de patients déprimés.

La dépression est fréquente chez la femme. Elle existe aussi chez le sujet âgé, dans 10 à 45 % des cas. On la trouve aussi chez l'enfant et l'adolescent dans 5 à 25 % des cas.

16 % des consultants toutes spécialités confondues est constitué de patients déprimés. On note aussi 20 % de dépression du postpartum. Au Maroc, une étude qui a été faite à l'échelle nationale et qui a concerné une large population, une population de 6 000 sujets, a objectivé une prévalence de l'épisode dépressif majeur de 26,5 %. Le syndrome dépressif, commun à toutes les formes de dépression, est constitué par une humeur dépressive, une souffrance morale, un ralentissement psychomoteur ou des fois on a une agitation et d'autres symptômes associés.

Tout d'abord, pour poser le diagnostic d'une dépression, il faut un début d'évolution des troubles de 15 jours. Au cours de l'anamnèse, il faut aussi chercher les facteurs déclenchants parce que vous allez traiter la dépression par les antidépresseurs. Il faut aussi agir sur les facteurs déclenchants pour éviter les rechutes ou les récives.

Les antécédents familiaux sont importants à chercher. Il faut chercher s'il y a une dépression, s'il y a des antécédents de suicide ou des antécédents de tentatives de suicide qui vont vous donner

une idée sur le pronostic de la dépression chez votre patient. Une chose aussi qui est importante, c'est chercher les antécédents familiaux d'hypomanie, de manie ou de tout autre trouble de l'humeur parce que ça peut changer carrément le traitement que vous allez prescrire à votre patient.

Et aussi, le fait qu'un patient déprimé ait des antécédents familiaux de troubles de l'humeur type hypomanie ou manie augmente chez ce patient le risque de virage maniaque sous antidépresseur. Au niveau des antécédents personnels, il faut bien chercher s'il y a des antécédents de dépression pour voir si votre patient présente la première dépression, la deuxième ou la troisième parce que la durée du traitement va changer. Chercher des tentatives de suicide, ça vous donne une idée sur le pronostic et le risque chez votre patient.

Et bien sûr, c'est capital de chercher les troubles de l'humeur type hypomanie ou manie dans les antécédents parce que ça va complètement changer le diagnostic et le traitement. Il faut aussi chercher les antécédents médicaux, chirurgicaux et toxiques pour voir si cette dépression a une utilité organique autre. Et bien sûr, parce que vous allez mettre votre patient sous traitement antidépresseur, il faut bien connaître les interactions avec les traitements que le patient prend déjà.

Au niveau de la présentation du patient, vous avez déjà des symptômes, des signes qui vont vous orienter pour le diagnostic de dépression. Donc au niveau du contact et la présentation, on a un ralentissement psychomoteur qui va se manifester par une mimique figée, des gestes qui sont longs, un regard qui est éteint, éternel, un discours qui est pauvre, une voix monotone avec une indécision. Le patient va vous répondre après un temps de latence.

Il prend du temps pour réfléchir même à des questions simples pour vous répondre. On note aussi au cours de l'entretien des pleurs faciles et on voit au niveau de la présentation une négligence vestimentaire parce que la patiente déprimée ne prend plus soin d'elle. Comme on a dit, parfois le ralentissement psychomoteur peut être remplacé par une irritabilité ou bien un comportement rigide, un comportement opposant, le patient qui va refuser de l'aide, qui va refuser les soins.

Et des fois même on peut noter un comportement agressif. La patiente peut présenter des agressivités verbales ou même physiques. Sur le plan intellectuel, le patient présente des troubles de l'attention, de la concentration, de la mémoire, une incapacité à rassembler ses idées.

Et ça va se manifester par cette lenteur à répondre aux questions. L'humeur dépressive, elle va se manifester par une tristesse. La tristesse au cours d'un syndrome dépressif est caractéristique, donc différente par rapport à la tristesse qu'on va rencontrer au cours d'un deuil ou bien au cours d'un événement traumatisant, d'un événement triste.

Donc cette tristesse, elle est persistante, elle est incontrôlable, elle est peu accessible au raisonnement et au soutien de la famille et elle est aussi peu accessible au réconfort de l'entourage, de la famille ou bien des amis. Et elle envahit tous les champs de la vie mentale, ainsi aussi elle entraîne une importante impotence fonctionnelle. On peut aussi noter une anesthésie affective.

Le patient étant hypo-réactif au stimulus agréable, il ne va pas participer aux joies de la famille ou au contraire, il présente une irritabilité, une labilité émotionnelle avec des crises, des larmes parfois inexpliquées par le patient. On note aussi un abaissement de l'humeur, une perte d'intérêt, une lassitude. C'est une grande fatigue, une anhédonie, c'est la perte de la sensation du plaisir.

Le patient ou bien la patiente n'a plus envie, n'a plus de plaisir à faire les choses qui lui faisaient plaisir auparavant. Donc on compare toujours sa vie présente par rapport à avant. Même les choses les plus simples, le fait de s'occuper de soi, le fait de s'occuper de ses enfants.

Avant elle aimait faire du sport, maintenant ça ne lui fait plus plaisir. Avant elle aimait sortir, s'amuser avec les amis, la famille, maintenant ça ne lui fait plus plaisir. Avant elle aimait lire, maintenant ça ne lui fait plus plaisir.

Donc c'est ce qu'on appelle l'anhédonie. L'abolie, c'est cette perte d'initiative à faire les choses, perte d'initiative à démarrer la journée, à faire des activités, à travailler, à étudier et cette absence d'envie à faire les activités et à faire des choses qu'avant le patient pouvait faire facilement. On note aussi une insatisfaction avec perte de l'estime de soi, un sentiment de vide, d'inutilité et d'impuissance, avec absence d'espoir et bien sûr quand on est déprimé, on ne fait pas de projet.

Au total, on a une modification du contenu de la pensée. Le patient voit le passé avec une reconstruction négative, donc quand vous lui posez la question, il vous dit que tout son passé, il n'y a que des malheurs. Le présent, il le vit avec une culpabilité exagérée, avec un vécu d'indignité, il se sent indigne, il se sent une charge pour la famille.

Il y a aussi de l'autodépréciation. L'avenir, il va le voir avec pessimisme, avec une sensation d'avenir bouché, ça ne sert à rien de faire des projets. Incurabilité, c'est le sentiment de ne pouvoir être guéri.

La souffrance morale ou la douleur morale, elle va se manifester par des idées noires, des idées suicidaires, un sentiment que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue, des idées récurrentes de mort, ça peut aller même à des plans suicidaires précis. Donc le patient peut exprimer ses idées spontanément, peut les verbaliser spontanément, verbaliser le souhait de mort, ou bien vous dire qu'il a des idées suicidaires, comme il peut le cacher. Dans ce cas, il est capital de poser la question, est-ce qu'il a des idées noires, est-ce qu'il a des idées suicidaires, et les idées suicidaires, est-ce qu'il pense à la mort, est-ce qu'il a des souhaits de mort, ou bien il pense à en

finir avec la vie lui-même.

Donc là, ça vous donne une idée sur la sévérité des troubles, une idée qui peut vous orienter pour hospitaliser le patient. Et ce n'est pas parce que vous allez lui poser la question que vous lui suggérez d'aller se suicider. On note aussi, au cours de la souffrance morale, un découragement et un dégoût de la vie, avec un sentiment douloureux d'indifférence, de monotonie, une solitude, un sentiment d'incapacité et d'abandon, une culpabilité ou une autodépréciation.

Il va se sentir coupable, qu'il ne s'occupe pas, par exemple, de ses enfants, coupable qu'il n'a plus de rendement à son travail comme avant, coupable parce qu'il a échoué à son examen. Donc, au total, une vision pessimiste de soi, du monde et de l'avenir. Le ralentissement psychomoteur, il va se manifester par une pauvreté gestuelle et mimique, un regard qui est sombre et perdu, un apragmatisme, c'est une perte totale d'initiative, une fatigue insurmontable.

Au final, on peut avoir des diminutions des conduites élémentaires d'hygiène et d'alimentation qui peuvent aller jusqu'à l'incurie. Le patient va être presque clochardisé, il ne prend plus soin de lui, mais c'est dans des états dépressifs sévères. Avec un confinement au lit, le patient va garder le lit sans dormir, il peut rester allongé toute la journée et toute la nuit sans dormir.

C'est ce qu'on appelle la clinophilie. On note aussi, dans ce ralentissement psychique, des troubles de l'attention, des troubles de la concentration, des troubles mnésiques qui peuvent mener à une indécision et une perplexité anxieuse. On note aussi des ruminations, surtout à l'endormissement, et une bradie féminine, une diminution du fluide verbal, qui va aller des fois jusqu'au mutisme et à la stupeur.

Donc, à part l'humeur dépressive, la souffrance morale et le ralentissement psychomoteur, on peut aussi noter d'autres symptômes qui font partie du syndrome dépressif, notamment l'anxiété, les troubles de sommeil, les troubles alimentaires, l'asthémie, les troubles sexuels, beaucoup de plaintes somatiques, des troubles du caractère et des symptômes psychotiques, sous forme de délirantes ou d'hallucinations. L'anxiété va se manifester par une anxiété psychique et une anxiété physique. Dans l'anxiété psychique, on va trouver des peurs qui sont mal définies, une tension qui est interne, une attente craintive, et bien sûr, au niveau physique, le patient peut présenter tachycardie, des boules dans la gorge, une bouche qui est sèche, des tremblements, des céphalées, tout le corps va s'exprimer.

Le trouble du sommeil, on peut trouver surtout des insomnies d'endormissement dans la dépression anxieuse, parce que le sujet à l'endormissement va présenter des ruminations anxieuses qui vont l'empêcher de s'endormir. On peut trouver des réveils matinaux précoces. Ces troubles de sommeil, si le patient ne les rapporte pas, il faut poser la question surtout sur les réveils matinaux précoces, parce que c'est à ces moments-là que les patients vont commencer à établir des plans suicidaires pour passer à l'acte.

Quelquefois, dans certains types de dépression, on va le voir par la suite, à la place de

l'insomnie, on peut trouver des hypersomnies. Dans tous les cas, le sommeil est non réparateur. Le lendemain, le patient est fatigué.

Les troubles alimentaires les plus fréquents sont l'anorexie, des fois aussi dans un type de dépression, la dépression saisonnière, on peut trouver l'hyperphagie. L'asthénie est quasi constante, surtout le matin, avec une amélioration vers la fin de l'après-midi. Dans les troubles sexuels, on trouve une diminution de la libido, parfois une impuissance sexuelle.

Concernant les plaintes somatiques, elles sont diverses, surtout représentées par les douleurs. Les douleurs ont des caractéristiques particulières, c'est des douleurs qui sont variables dans le temps et dans l'intensité. Des fois, c'est très intense le matin, des fois ça s'améliore le soir, des fois c'est le contraire.

Elles ne sont pas améliorées par les ondes algiques, parce que le traitement pour ces douleurs, c'est les ondes dépresseurs. Elles ne sont pas expliquées par une pathologie organique, ni au niveau de leur localisation, ni au niveau de leur irradiation. Les plus souvent retrouvées sont les céphalées et les cervicales G. On peut trouver tous types de troubles, donc des troubles cardiovasculaires, des troubles digestifs, des troubles urinaires, des troubles neuromusculaires, qui sont très variés.

Les troubles du caractère sont surtout fréquents chez l'adolescent et chez les sujets qui présentent une personnalité pathologique antérieure, surtout des traits de personnalité antisociale. On trouve trois types de signes. L'irrétabilité, particulièrement exacerbée, avec une impatience et une impulsivité, qui est remarquée par l'entourage.

On peut trouver de l'hétéroagressivité, de l'autoagressivité, avec automutilation, des conduits toxicomaniaques ou alcooliques. Dans le syndrome dépressif, on trouve aussi des idées ou bien des symptômes psychotiques, notamment des idées délirantes. Ces idées délirantes sont congruentes à l'humeur, congruentes à l'humeur triste.

Ce sont des idées qui vont être négatives, des idées de ruine, d'indignité, de culpabilité. Le patient va se sentir une charge pour la famille, dit qu'il ne vaut rien, qu'il préfère mourir, que personne ne l'aime, qu'on cherche à lui faire du mal. Et des fois, on peut trouver ce qu'on appelle le syndrome de Cotard.

Ce sont des idées délirantes de négation d'organes ou bien carrément de négation du corps. Le patient, par exemple, peut vous dire « Moi, je ne veux pas manger, je ne peux pas manger parce que je n'ai pas de zoophage. » Alors, en résumé, on trouve trois types de symptômes.

Des symptômes émotionnels, type culpabilité, irritabilité, anxiété, aboli, tristesse, anhédonie, douleur morale. Des symptômes cognitifs, type troubles cognitifs, troubles de concentration, rumination obsessive, perte d'intérêt, repli social, idées suicidaires. Et des symptômes physiques, troubles de l'appétit, les douleurs, les troubles du sommeil, les modifications psychomoteurs et la

fatigue.

Alors ça, c'était le syndrome dépressif qui est commun à toutes les formes de dépression qu'on va voir par la suite. Et bien sûr, le patient ne va pas présenter tous les symptômes qu'on a vus dans les différents composants du symptôme dépressif, mais il peut présenter des symptômes variés. La première forme clinique qu'on va voir est l'épisode dépressif majeur.

Le premier type de dépression qu'on va définir est l'épisode dépressif majeur, qui est l'épisode dépressif caractérisé. On peut l'utiliser comme type de description. Il est défini selon le DSM.

Le DSM, c'est le Manual de Diagnostic et Statistique des Maladies, par un certain nombre de critères. Le critère A, il faut au moins 5 des symptômes, des symptômes de A1 à A9 suivants, pendant deux semaines, avec un changement par rapport à l'état antérieur. Et au minimum, il faut soit l'humeur dépressive, soit une diminution marquée du plaisir ou de l'intérêt.

On peut avoir les deux, mais il faut au moins un de ces deux symptômes. Après, il peut y être associé 3 ou 4 des autres symptômes. Ça ne doit pas être un épisode mixte.

On va voir la définition de l'épisode mixte dans le cours de troubles bipolaires. Ça doit entraîner une souffrance clinique, sociale, professionnelle et familiale. Ça ne doit pas être en rapport avec une prise de substances ou une infection médicale, et pas en rapport avec un deuil.

L'épisode dépressif majeur ne veut pas dire sévère, mais ça veut dire une dépression caractérisée. Si vous voulez, c'est son nom. Un épisode dépressif dont on a vu les caractéristiques les plus classiques et les plus fréquentes, c'est l'épisode dépressif majeur.

La sévérité est évaluée en fonction du nombre de symptômes et du retentissement. On distingue l'épisode dépressif majeur d'intensité léger, l'épisode dépressif majeur d'intensité moyenne et l'épisode dépressif majeur d'intensité sévère. Et bien sûr, à chaque fois, il faut préciser s'il y a des caractéristiques psychotiques ou pas.

Le deuxième type qu'on va citer, c'est la dépression sur le sujet âgé. Parmi les caractéristiques, on note un changement de comportement. Ce sont des caractéristiques qu'on trouve souvent chez le sujet âgé, même sans dépression, mais qui vont s'aggraver avec la dépression.

Un sentiment de faiblesse générale, une fatigabilité rapide, des troubles menisiques, des palpitations, des douleurs diverses, des vertiges et l'impression d'étouffer. Donc, avant tout, il faut d'abord éliminer une pathologie organique autre, pour ne pas passer à côté d'une pathologie qu'on peut traiter par d'autres médicaments. Le troisième type est la mélancolie.

La mélancolie, c'est un épisode dépressif majeur d'intensité très sévère, dont les symptômes sont exacerbés. Le risque suicidaire dans ce type de dépression, il est majeur. Donc, on a au moins un des éléments suivants.

Une anhédonie généralisée. Cette envie de rien faire, cette perte de plaisir et d'intérêt, elle est généralisée. Une aréactivité au stimulus agréable.

Donc, carrément une aréactivité, le sujet ne va plus partager les joies de la famille, même la naissance d'un enfant, même la réussite d'un concours, même l'arrivée d'un être cher, le sujet ne va rien ressentir. Au moins, on a trois des éléments suivants. Une humeur dépressive qui est marquée.

On a tous les symptômes de l'humeur dépressive. Donc, leur intensité et leur nombre sont très importants, avec une prédominance des symptômes matinaux et un réveil matinal précoce. Donc, le réveil matinal précoce, il y a le risque de passer à l'acte, le risque suicidaire.

Dans ce type de dépression, on a une anorexie, bien sûr, avec perte de poids parce que le patient peut refuser carrément de manger pendant des jours. On a aussi une culpabilité excessive et inappropriée. Le patient va se culpabiliser pour des choses banales.

Alors, dans ce type de dépression, c'est vrai que c'est une dépression qui est très sévère, mais on peut avoir des réponses favorables au traitement médicamenteux. Le quatrième type de dépression qu'on va voir, c'est la déstymie. Alors, la déstymie, elle est définie par un trouble dépressif d'intensité moyenne avec une durée d'évolution égale ou supérieure à deux ans.

Dans ce type de dépression, on note une comorbidité importante, surtout avec les troubles anxieux, avec les troubles de personnalité, et il prédomine surtout chez les femmes. On note aussi l'existence d'une personnalité dépressive, un fléchissement de l'humeur, des symptômes neuro-végétatifs et des symptômes cognitifs. Aussi, on a des symptômes psychomoteurs.

La durée, comme on a dit, de ce type de dépression, il doit y avoir une évolution de deux ans et les symptômes doivent survenir au moins un jour sur deux. S'il n'est pas traité, ce type de dépression va évoluer vers la chronicisation, vers le risque de tentative de suicide, les conduites addictives, les troubles de personnalité. Sous traitement, la prise en charge, elle est longue et peut aller jusqu'à cinq ans, mais on note des améliorations.

On utilise bien sûr des antidépresseurs, surtout les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Parfois, on peut y associer des tumeurs régulateurs et aussi l'association avec la thérapie cognitive ou comportementale donne de meilleurs résultats dans ce type de dépression. Les autres formes de dépression, brièvement, on a les dépressions saisonnières.

Ce sont des dépressions qui surviennent l'hiver et qui vont disparaître le printemps. Dans ce type de dépression, on va trouver le syndrome dépressif qu'on a vu tout à l'heure, mais il va y avoir aussi de l'hypersomnie à la place de l'insomnie et de l'hyperphagie, surtout au sucré. Et bien sûr, il va y avoir une prise de poids.

Les dépressions brèves, récurrentes, ce sont des dépressions qui vont durer trois jours. Après, il

va y avoir une amélioration. C'est vrai que l'évolution de la maladie n'attend pas deux semaines, mais il peut y avoir deux jours, une dépression, amélioration, quelques jours, réapparition des symptômes dépressifs.

Ça, c'est un type de dépression qui pose un problème diagnostique et thérapeutique. Les dépressions chroniques, c'est des dépressions qui vont durer plus de deux ans. Alors, qu'est-ce qu'il y a par une dépression et où on peut trouver des fois des symptômes du syndrome dépressif? Tout d'abord, il faut faire un examen clinique complet pour éliminer une affection organique.

Si on a une affection organique, on va parler de dépression secondaire à une affection organique, et bien sûr, il faut traiter les deux. Le deuil, ce n'est pas une dépression parce que tout le monde a le droit de faire son deuil. Le deuil, en général, peut durer deux mois.

Si ça dépasse deux mois, on est dans le deuil pathologique et ça peut se compliquer d'une dépression. La tristesse qu'on va rencontrer au cours d'un deuil ou bien au cours d'un événement négatif, c'est une tristesse qui va répondre au réconfort et au soutien de la famille. Les troubles anxieux, vous allez voir par la suite les troubles anxieux.

Tous les troubles anxieux qu'on va voir, ce sont des troubles qui ont des symptômes et des caractéristiques particulières qui vont vous aider à faire la différence avec la dépression. Mais les troubles anxieux, s'ils ne sont pas bien traités et si ça dure, ils peuvent se compliquer d'une dépression. Les troubles démentiels chez les sujets âgés peuvent, au début, commencer par un état dépressif.

Il faut toujours faire un examen neuropsychologique chez le patient pour voir s'il n'y a pas des démences derrière. Concernant l'ithiopathogénie, comme tous les troubles psychiatriques, la dépression n'a pas une cause précise mais elle a plusieurs facteurs déclenchants. C'est multifactoriel.

Il y a des facteurs prédisposants, des facteurs génétiques, des facteurs familiaux et de personnalité. On a des cas de famille où on a beaucoup de sujets qui présentent des dépressions. Il y a des facteurs environnementaux, des stressors extérieurs, psychosociaux, des événements de vie.

Et on a aussi des facteurs biologiques. C'est pour ça qu'on traite par les antidépresseurs. C'est la baisse de neurotransmetteurs, la sérotonine, la noradrénaline et la dopamine dont la feuille synaptique qui sont décrites comme une cause biologique de la dépression.

On note aussi sur le plan biologique une atrophie de l'hippocampe, des lésions préfrontales, des lésions de l'amygdale et du noyau de la base. On note aussi des lésions vasculaires de la substance blanche et une baisse de BDNF. Le BDNF, c'est un facteur qui permet d'assurer la survie des neurones du système nerveux.

Il pourrait également intervenir dans la formation des circuits neuronaux. Il a un rôle dans la plasticité synaptique, c'est-à-dire dans les modifications morphologiques et physiologiques des synapses. La production du BDNF par les antidépresseurs va entraîner un blocage de l'inhibition de la neurogénèse.

Ça veut dire qu'il va entraîner, il va améliorer la neurogénèse dans l'hippocampe et la maintenance des neurones et de la glyphe. L'évolution de la dépression, vous voyez selon ce graphique, on a une zone de variation physiologique de l'humeur. Quand on descend très bas, on a une humeur dépressive.

Et en général, on est dans cette zone. Le timide, au niveau zéro, en général, on ne l'atteint pas. Mais on varie dans une zone physiologique.

L'évolution sous traitement de la dépression, on peut noter une réponse positive si on a une amélioration des symptômes à 50%. Cela, on le fait grâce à des échelles d'évaluation. On peut parler de rémission quand on a une disparition des symptômes à 95%.

On parle de guérison quand on a une rémission qui va durer plus de quatre mois. On parle de rechute quand on a la réapparition des symptômes avant la guérison. Et on parle de récurrence en récurrence quand on a une réapparition des symptômes après la guérison.

En général, après le premier épisode dépressif, on a 50% de risque de récurrence. Après le deuxième épisode dépressif, on a 70% de risque de récurrence. Après le troisième épisode dépressif, on a 90% de risque de récurrence.

C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure qu'il faut demander les antécédents de dépression chez votre patient. Sous-traitement aussi, on peut voir le passage à la chronicité et on peut avoir une résistance au traitement. Et sous-traitement, on peut avoir un virage maniaque sous antidépresseur.

Voici le schéma qui va vous montrer la rémission, les réponses et surtout les rechutes. C'est la réapparition des symptômes avant la guérison, la récurrence ou la récurrence, la réapparition des symptômes après la guérison. L'évolution en l'absence du traitement va se faire soit vers des conduites suicidaires, soit vers des conduites addictives, soit vers des retentissements socioprofessionnels, entraîner la souffrance du patient, la souffrance de l'entourage, l'absentisme au travail, l'absentisme scolaire, la diminution du rendement, soit vers la récurrence, soit vers l'évolution vers un trouble chronique de l'humeur.

Le traitement est basé sur le traitement médicamenteux et la psychothérapie. Pourquoi traiter ? D'abord pour réduire la souffrance et l'incapacité du sujet pour diminuer le risque suicidaire, pour réduire la durée de l'épisode et, bien sûr, l'objectif du traitement est la guérison. La règle dans une dépression, c'est la guérison sous traitement antidépresseur.

Le traitement est basé sur les antidépresseurs. On peut y associer, ce n'est pas systématique, des fois des benzodiazépines, la psychothérapie de soutien, donc c'est essentiel, les psychothérapies comportementales et cognitives, la l'immunothérapie, ça c'est dans la dépression saisonnière, les neuroleptiques, en cas de symptômes psychotiques, des idées délirantes ou bien des hallucinations. On peut trouver d'autres types de psychothérapie, notamment la psychanalyse, le EMTR et on a aussi le traitement par l'électroconvulsivothérapie, la sismothérapie.

Dans la dépression saisonnière, on utilise la l'immunothérapie ou bien la photothérapie. La sismothérapie, c'est un traitement d'urgence dans le cas des mélancolies délirantes et stupéuses. Et dans ce type de dépression, elle donne des fois des résultats spectaculaires.

Dès la première sismothérapie, le patient peut se réveiller, commencer à manger et s'améliorer. Des fois, elle est prescrite en troisième ligne dans les dépressions sévères et résistantes. Donc on va utiliser d'abord les antidépresseurs, on va utiliser les antidépresseurs associés à d'autres médicaments, et en troisième ligne, utiliser la sismothérapie.

C'est un traitement qui est efficace. Ici, vous avez un tableau des antidépresseurs les plus utilisés, du stimulant vers le sidatif. Donc vous allez le voir en détail dans le cours des antidépresseurs.

Et vous allez voir, vous voyez selon ce tableau, il y a des antidépresseurs qui sont pris une fois par jour et d'autres qui sont pris deux ou trois fois par jour. Donc selon la dose et selon la molécule. Le choix des antidépresseurs, il dépend de la sémiologie de la dépression.

Il y a des dépressions où on a beaucoup plus d'anxiété, beaucoup plus d'irritabilité, et il y a des dépressions où on a beaucoup plus de la fatigue et du ralentissement. Donc pour les dépressions où on a de l'anxiété et de l'irritabilité, on va donner des antidépresseurs sidatifs. Dans les dépressions où on a beaucoup plus de la fatigue et du ralentissement, on peut donner des antidépresseurs stimulants.

Donc ça dépend aussi des antécédents du patient, les antécédents médicaux, les antécédents chirurgicaux et les médicaments qu'il prend. Ça dépend de l'âge, ça dépend aussi des pathologies associées et ça dépend de l'habitude du prescripteur. Alors les associations médicamenteuses, comme on a dit, ça peut se faire avec les benzodiazépines ou bien avec d'autres médicaments pour augmenter l'efficacité des antidépresseurs.

Alors il faut augmenter progressivement les antidépresseurs, sauf pour les nouveaux médicaments, pour les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. En général, on les donne une fois par jour. Il y a d'autres médicaments comme vous avez vu sur le tableau qui sont pris deux ou trois fois par jour.

Le délai d'action en général de tous les antidépresseurs, c'est trois à quatre semaines. Ce n'est

pas des traitements miracles, ça prend du temps pour commencer à agir. Donc il faut prévenir le patient sur ce délai d'action, pour qu'il n'arrête pas le traitement après une semaine ou deux, quand il ne voit pas l'amélioration.

Le prévenir aussi sur les effets secondaires, surtout sur le risque du virage maniaque. Dès qu'il a un virage maniaque, il doit arrêter le traitement et venir vous consulter. La durée du traitement, elle est en général de huit à onze mois.

Donc en moyen, c'est neuf mois de traitement. On fait une diminution progressive sur trente jours à un mois et demi. Pourquoi il faut traiter au long cours? Des fois, parce que c'est un trouble qui est récurrent et parce que plus on a de dépression, plus le risque de récurrence augmente.

Et en général, à partir du troisième épisode dépressif, il y a 90% de risque de récurrence. C'est pour ça que il est conseillé des fois de garder le traitement pendant cinq ans, ou bien même deux fois à vie quand on est au troisième épisode dépressif. Cherchez aussi les facteurs de risque de récurrence, qui sont le nombre d'épisodes antérieurs, la sévérité de l'épisode actuel, le jeûnage de début, les signes dysthymiques, les comorbidités psychiatriques et physiques.

Cherchez les facteurs de sévérité pour faire attention à la dépression de votre patient. Les épisodes antérieurs avec les tentatives de suicide, ça augmente le risque chez votre patient de passer à l'acte. Les aspects psychotiques, aussi ça augmente le risque de passer à l'acte.

Les perturbations sévères du fonctionnement. 30% des patients gardent des symptômes résiduels et des perturbations sociales et professionnelles. C'est pour ça qu'il faut un traitement en long cours.

Parmi les facteurs de risque de chronicité, on note le début précoce, le sujet âgé et les symptômes résiduels et la douleur. Attention aux pièges de prescription des antidépresseurs qui sont le non-respect des indications, ne pas utiliser les antidépresseurs sans un diagnostic précis. Faites bien attention que c'est une dépression et qu'il n'y a pas un autre trouble de l'humeur sous-jacent, qu'il n'y a pas des antécédents d'hypomanie ou de manie chez votre patient.

Faites attention à la banalisation des antidépresseurs, surtout le risque de virage maniaque et les effets secondaires, même s'ils sont bien tolérés. Le non-respect des contre-indications, donc le patient peut avoir des effets secondaires graves, il peut arrêter le traitement. Mauvaise adaptation posologique, donc si vous sous-dosez votre patient, il peut ne pas s'améliorer et ne plus revenir vous voir et son état peut s'aggraver et il peut passer à l'acte suicidaire.

Le changement d'antidépresseur pour inefficacité avant délai, comme on a dit, tous les antidépresseurs se valent et tous ont un délai d'action de 3 à 4 semaines, donc il faut se donner le temps avant de changer l'antidépresseur. L'association médicamenteuse inutile, ce n'est pas la peine, ça ne fait qu'augmenter les effets secondaires et arrêter un antidépresseur efficace est un piège aussi, parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. En général, on revient toujours à

l'antidépresseur qui a donné efficacité la première fois chez le même patient.

Quand hospitalisé, en cas de mélancolie, il y a le risque suicidaire élevé pour hospitaliser le patient, en cas de dépression sévère avec risque suicidaire élevé, en cas de mode de vie entretenant les troubles, et des fois quand on n'arrive pas à décider, on se pose la question de ce qui est mieux pour le patient. Là, je vous présente un outil de diagnostic simple pour les médecins généralistes, selon les critères du DSM, pour pouvoir poser le diagnostic chez votre patient, pour ne pas passer à côté d'une dépression chez votre patient. C'est rapide, et c'est simple.

La dépression, c'est une maladie en elle-même. Elle est caractérisée par un syndrome dépressif, comme on a vu, qui est commun aux différentes formes de la dépression. C'est un enjeu majeur de santé publique et bénéficie de campagnes d'informations de plus en plus intenses pour permettre au grand public d'obtenir une autre vision de la maladie, et par conséquent d'améliorer le nombre de consultations, de prises en charge et donc de rémission de la maladie.

Merci.